

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	ST-CAS18-F	
	Versión: 001	
	Fecha: 08/06/2022	
INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 1 de 16

I. DATOS GENERALES

Nombre: Antonio Isaac Hernández Valencia	Edad: 11 años
Escolaridad: Sexto grado	Fecha de nacimiento: 20/07/2014
Ocupación: Estudiante	Fecha de evaluación: Septiembre/2025
Evaluador: Antonio Amaris Ariza	

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente masculino de 11 años de edad que asiste a valoración neuropsicológica referido por con el propósito de establecer perfil cognitivo.

II. INSTRUMENTOS

Se aplicaron 9 instrumentos evaluativos, los instrumentos utilizados fueron:

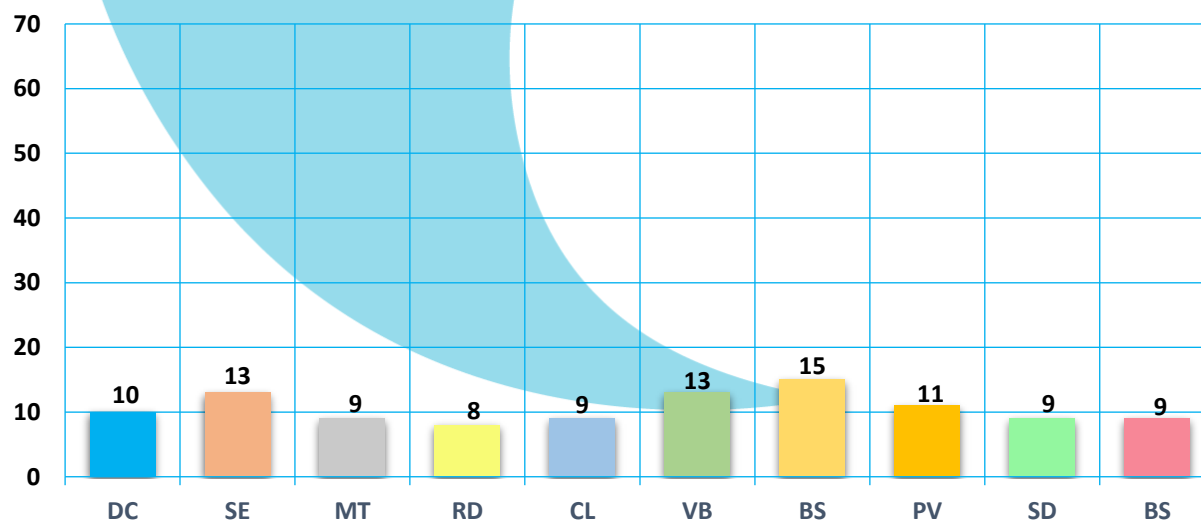
- Escala Wechsler de inteligencia para niños (WISC-V).
- Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (EDAH) en el hogar y en la escuela.
- Escala de comportamiento (SNAP-IV) para el hogar y la escuela.
- Test de las CARAS-R.
- Escala de evaluación TDAH-5 para el hogar y la escuela.
- Inventario de depresión infantil CDI.
- Escala de Ansiedad Infantil de SPENCE.
- Test estilo de aprendizaje (modelo PNL).
- Escala de autoestima de Rosenberg.

III. RESULTADOS

Escala Wechsler de inteligencia para niños (WISC-V)

SUBPRUEBA	PUNTUACIÓN NATURAL	PUNTUACIONES ESCALARES					
Cubos	30		10				10
Semejanzas	35	13					13
Matrices	17			9			9
Dígitos	23				8		8
Claves	45					9	9
Vocabulario	35	13					13
Balanzas	27			15			15
Puzles visuales	17		11				(11)
Span de dibujos	27				9		(9)
Búsqueda de símbolos	24					9	(9)
Suma de puntuaciones escalares		26	21	24	17	18	77
		C.V	V.E	R.F	M.T	V.P	CIT

Perfil de puntuaciones escalares de subpruebas



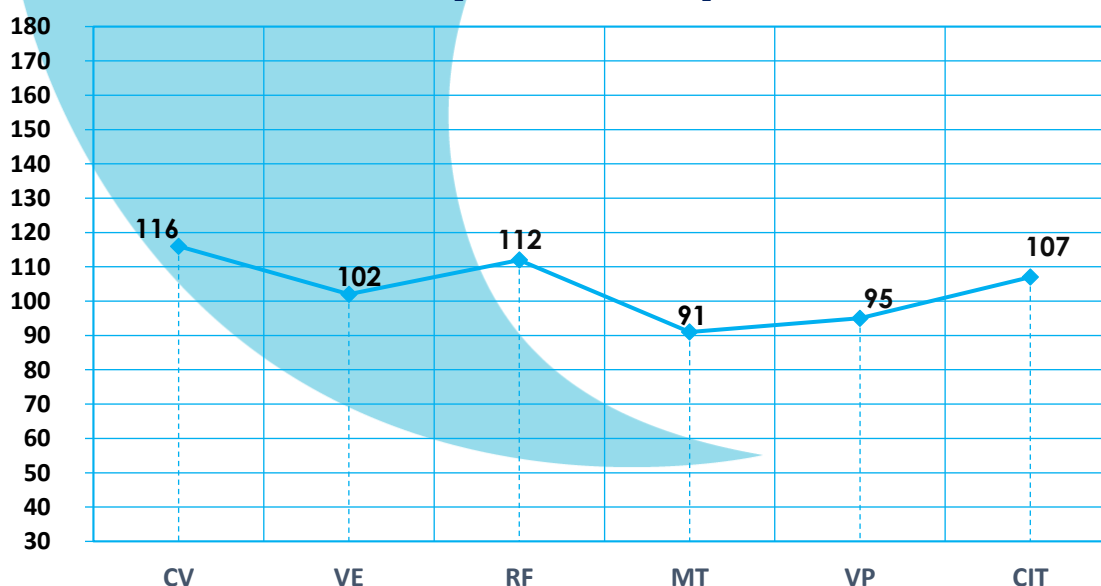
	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 3 de 16

Cálculo de puntuaciones índice

ESCALA	Suma de puntuaciones escalares	Índice compuesto	Rango percentil	Intervalo de confianza 95%	Valor cualitativo
Comprensión verbal	26	116	86	106-123	Promedio medio-alto
Visoespacial	21	102	55	93-110	Promedio
Razonamiento fluido	24	112	79	104-118	Promedio medio-alto
Memoria de trabajo	17	91	27	94-100	Promedio
Velocidad de procesamiento	18	95	37	87-105	Promedio
Escala Total	77	107	68	68-81	Promedio

Interpretación del coeficiente intelectual: 100 - 109 promedio.

Perfil de puntuaciones compuestas



	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 4 de 16

- Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (EDAH).

Docentes	H	DA	H+DA	TC	H+DA+TC	Valor cualitativo
PD	3	7	10	4	14	Paciente que se encuentra por debajo de la media de corte en TDAH e impulsividad y trastorno de conducta.
Centil	35	80	65	55	60	

Padres	H	DA	H+DA	TC	H+DA+TC	Valor cualitativo
PD	5	4	9	2	11	Paciente que se encuentra por debajo de la media de corte en TDAH e impulsividad y trastorno de conducta.
Centil	60	55	55	40	50	

- Escala de comportamiento (SNAP-IV) para el hogar. En la subescala de inatención obtiene una puntuación de **1.56** encontrándose por encima del punto de corte con relación a lo esperado para su edad. Por otra parte, en la subescala de hiperactividad e impulsividad alcanza una puntuación de **0.44** encontrándose por debajo del punto de corte. Estos resultados indican que la menor evidencia signos relacionados con trastorno de déficit de atención, combinado con hiperactividad e impulsividad. Estos resultados indican que en el contexto familiar el menor, evidencia signos relacionados con trastorno de déficit de atención.
- Escala de comportamiento (SNAP-IV) para la escuela. En la subescala de inatención obtiene una puntuación de **1.33** encontrándose por debajo del punto de corte con relación a lo esperado para su edad. Por otra parte, en la subescala de hiperactividad e impulsividad alcanza una puntuación de **0.11** encontrándose por debajo del punto de

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	
	ST-CAS18-F	Versión: 001
	Fecha: 08/06/2022	Página 5 de 16

corte. Estos resultados indican que en el contexto escolar el menor, no evidencia signos relacionados con trastorno de déficit de atención con hiperactividad/impulsividad.

- **Escala de evaluación TDAH-5 para el hogar.**
para padres se obtienen los siguientes resultados:
 - ✓ ESCALA 1 Predominante Inatento: percentil 86 (**ALTO**).
 - ✓ ESCALA 2 Predominante hiperactivo/impulsivo: percentil 75 (**BAJO**).
 - ✓ ESCALA 3 Combinado déficit de atención e hiperactividad: percentil 80 (**ALTO**).

Dominios de deterioro en el que el TDAH se hace presente:

- ✓ Relaciones familiares: percentil 93 (**ELEVADO**).
- ✓ Relaciones con los pares: percentil 75 (**BAJO**).
- ✓ Tareas: percentil 99 (**ELEVADO**).
- ✓ Desempeño académico: percentil 99 (**ELEVADO**).
- ✓ Conducta: percentil 99 (**ELEVADO**).
- ✓ Autoestima: percentil 93 (**ELEVADO**).

De acuerdo con los resultados de la prueba, el paciente presenta un número **ALTO** de síntomas característicos del TDAH, predominando en inatención, los cuales se manifiestan en las relaciones familiares, en las tareas, en el desempeño académico, en la conducta y en la autoestima.

- **Escala de evaluación TDAH-5 para la escuela.**
para la escuela se obtienen los siguientes resultados:
 - ✓ ESCALA 1 Predominante Inatento: percentil 50 (**BAJO**).
 - ✓ ESCALA 2 Predominante hiperactivo/impulsivo: percentil 50 (**BAJO**).
 - ✓ ESCALA 3 Combinado déficit de atención e hiperactividad: 50 percentil (**BAJO**).

Dominios de deterioro en el que el TDAH se hace presente:

- ✓ Relaciones con los maestros: percentil 65 (**BAJO**).
- ✓ Relaciones con los pares: percentil 85 (**ALTO**).

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	ST-CAS18-F	
	Versión: 001	
	Fecha: 08/06/2022	
INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 6 de 16

- ✓ Tareas: percentil 99 (**ELEVADO**).
- ✓ Desempeño académico: percentil 99 (**ELEVADO**).
- ✓ Conducta: percentil 50 (**BAJO**).
- ✓ Autoestima: percentil 98 (**ELEVADO**).

De acuerdo con los resultados de la prueba, la paciente presenta un número **BAJO** de síntomas característicos del TDAH, los cuales se manifiestan en las relaciones con los pares, en las tareas, en el desempeño académico y en la autoestima.

- **Inventario de depresión infantil CDI:** Obtiene una puntuación directa de **12**, que lo ubica de acuerdo con su edad y género en un percentil de **60**, lo cual sugiere que no hay sintomatología relacionada con depresión infantil.
- **Escala de Ansiedad Infantil de SPENCE.**
El menor obtuvo una puntuación directa de **38**, lo cual indica que presenta sintomatología leve relacionada con ansiedad infantil.
- **Escala de autoestima de Rosenberg:** Obtiene una puntuación directa de **30/40**. Lo cual indica una autoestima elevada, considerado como una autoestima normal.
- **Test estilo de aprendizaje (modelo PNL).**

CANAL PERCEPTUAL	PUNTUACION
Visual	7
Auditivo	15
Cinestésico	18

De acuerdo con los resultados de la prueba, el canal perceptual con mayor puntuación fue el **cinestésico** con una puntuación directa de **18**, lo que indica que es el canal perceptual dominante.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 7 de 16

▪ **Test de las CARAS-R:**

Los resultados arrojados por el paciente fueron los siguientes:

✓ **Aciertos (A):** Puntuación directa 50 Eneatipo 8

El paciente obtuvo un total de 50 aciertos, lo cual es considerado como un rendimiento normal.

✓ **Errores (E):** Puntuación directa 2 Eneatipo 8

De acuerdo a los criterios de la prueba, el paciente comete muchos errores.

✓ **Aciertos netos (A-E):** Puntuación directa 48 Eneatipo 8

El nivel de aciertos netos es alto según los criterios de eneatis del test Caras-R, es decir, reflejan una adecuada capacidad visoperceptiva y atencional, el paciente es capaz de atender a los detalles y de realizar un número adecuado de juicios correctos.

✓ **Índice de control de impulsividad (ICI):** Puntuación directa 92 Eneatipo 4

El nivel de control de impulsividad del paciente es adecuado, similar a la media de la población, ejecutando de forma reflexiva la tarea.

	PD	PT	En	RANGO
A	50	90	8	Alto
E	2	90	8	Alto
A-E	48	90	8	Alto
ICI	92	30	4	Medio

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que el rendimiento del paciente en la prueba es alto (A-E, En= 8) sin embargo, presenta un nivel de control de la impulsividad medio (ICI, En= 4). En este caso, comete un número alto de errores (E, En:8), pero responde correctamente a un número de ítems dentro de lo esperado para su rango de edad, (A, En:8), lo que puede estar influenciado por la existencia de aciertos al azar. Este perfil podría sugerir un subtipo impulsivo.

Notas: *Presenta fatiga atencional.*

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
			Página 8 de 16

ANÁLISIS CLÍNICO

Coeficiente Intelectual Total

El rendimiento global obtenido por *Antonio* en la escala de inteligencia evidencia un funcionamiento dentro del rango **promedio**, lo que indica que cuenta con las habilidades cognitivas necesarias para afrontar las demandas escolares habituales. Su perfil refleja una buena capacidad de razonamiento, comprensión y resolución de problemas, aunque presenta diferencias internas que afectan la consistencia de su desempeño. Específicamente, se observan áreas de fortaleza en la comprensión verbal y el razonamiento fluido, y una menor eficacia en la memoria de trabajo. Esta dispersión interna sugiere que, si bien posee recursos intelectuales adecuados, puede tener dificultades para mantener un rendimiento homogéneo cuando las tareas exigen mantener la atención sostenida o manipular información mentalmente.

Atención y Concentración

El emnor mostró un desempeño general adecuado en tareas que implican atención selectiva y velocidad de respuesta, aunque con indicios de *fatiga atencional* y una tendencia a disminuir su nivel de concentración conforme aumenta la carga o la duración de la tarea. Los resultados del test de Caras-R reflejan una *buena precisión inicial* y una *adecuada discriminación visual*, aunque con un número mayor de errores que sugiere impulsividad leve y dificultad para sostener el control atencional de manera estable.

En el contexto familiar se observan signos consistentes con inatención, mientras que en el ámbito escolar estos se reportan como leves. Este patrón indica que la capacidad de atención de *Antonio* puede verse comprometida en entornos poco estructurados o cuando las tareas no despiertan su interés, siendo más eficiente cuando existe motivación o guía directa del adulto.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	ST-CAS18-F
		Versión: 001
		Fecha: 08/06/2022
		Página 9 de 16

Memoria

El desempeño en memoria de trabajo fue **promedio**, reflejando un funcionamiento adecuado para su edad, logra retener y manipular información de manera efectiva. Su desempeño sugiere que los procesos de codificación y recuperación están preservados y que las posibles fluctuaciones se relacionan más con la atención y el control del foco que con fallas mnemónicas propiamente dichas. En consecuencia, la memoria de trabajo de *Antonio* es funcional y suficiente para el aprendizaje escolar, aunque puede beneficiarse de apoyos estructurados como la segmentación de instrucciones y el uso de recordatorios visuales.

Razonamiento Fluido

El rendimiento de *Antonio* demuestra una capacidad para analizar situaciones nuevas, descubrir patrones y establecer relaciones lógicas entre los elementos de un problema. Comprende con facilidad principios abstractos y logra aplicarlos de manera flexible para generar soluciones adecuadas, incluso ante estímulos poco familiares.

Este nivel de razonamiento favorece el aprendizaje conceptual y la comprensión de contenidos que requieren inferencia o análisis lógico, especialmente cuando las consignas son precisas y el entorno de trabajo está bien estructurado. Su estilo de pensamiento es analítico, organizado y coherente, lo que le permite abordar las tareas con claridad y sentido estratégico, mostrando un razonamiento maduro para su edad.

Habilidades Visoespaciales

Las habilidades visoespaciales de *Antonio* se ubican en un nivel promedio y funcional, mostrando una adecuada coordinación perceptiva y capacidad para integrar información visual en tareas constructivas. Comprende bien las relaciones espaciales y logra reproducir configuraciones visuales con precisión aceptable.

Sin embargo, su rendimiento tiende a disminuir cuando debe mantener simultáneamente la atención y la organización secuencial, lo que podría reflejar interferencia por sus dificultades

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 10 de 16

de memoria operativa. No obstante, su percepción visual básica y su razonamiento no verbal se encuentran preservados.

Velocidad de Procesamiento

El desempeño de *Antonio* en las tareas que miden la velocidad de procesamiento se ubica dentro del rango **promedio**, lo que indica que puede realizar actividades que exigen rapidez y precisión visual de manera funcional. Sin embargo, su estilo de trabajo tiende a ser más pausado y reflexivo que acelerado, priorizando la exactitud sobre la inmediatez. Esta forma de responder puede llevarlo a necesitar un poco más de tiempo en ejercicios extensos o repetitivos, especialmente cuando debe coordinar simultáneamente la percepción visual con la ejecución motora.

Aunque no presenta lentitud significativa, es posible que bajo presión temporal disminuya su eficiencia o cometa pequeños errores por fatiga.

Lenguaje

El lenguaje representa una de las áreas más sólidas en el perfil cognitivo de *Antonio*. Su comprensión verbal es clara y precisa, mostrando facilidad para captar el significado de las palabras, establecer comparaciones y expresar ideas con coherencia. Posee un vocabulario amplio para su edad y logra utilizarlo adecuadamente en diferentes contextos, lo que evidencia un buen desarrollo del pensamiento verbal.

Durante la evaluación se observó que responde con seguridad a las preguntas y explica sus razonamientos con orden lógico. Cuando las instrucciones son extensas o se le presentan varios pasos seguidos, puede necesitar que se le repitan para mantener la secuencia, no por falta de comprensión, sino por pequeñas fluctuaciones en la atención. En general, su lenguaje es fluido, comprensible y constituye una fortaleza que respalda su aprendizaje escolar y su interacción cotidiana.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 11 de 16

Funciones Ejecutivas

En el dominio ejecutivo se evidencian limitaciones en la autorregulación atencional y la organización secuencial. Su desempeño sugiere que presenta una adecuada planificación inicial, pero tiende a dispersarse ante tareas largas o con múltiples pasos. El control inhibitorio es aceptable, aunque muestra ocasionales respuestas impulsivas, especialmente cuando se le exige rapidez o se encuentra bajo presión.

Estos rasgos indican una inmadurez relativa del sistema ejecutivo, que repercute principalmente en la gestión del tiempo, la planificación de tareas escolares y la capacidad para revisar sus propios errores. No obstante, conserva recursos cognitivos que permiten una buena respuesta a intervenciones estructuradas y entrenamiento en autorregulación.

Gnosias y Praxias

Las gnosias visuales, auditivas y táctiles se encuentran **conservadas**, mostrando adecuada identificación de estímulos, reconocimiento de formas y comprensión de secuencias perceptivas. Las praxias ideomotoras y constructivas también se ubican dentro de la normalidad, reflejando una correcta planificación motriz y coordinación fina.

No se observan signos de torpeza motora significativa ni dificultades en la ejecución de gestos aprendidos, lo cual respalda la eficiencia de los procesos perceptivo-motores básicos necesarios para el aprendizaje.

Aspectos Emocionales, Conductuales y Contextuales

A nivel emocional, *Antonio* presenta una autoestima adecuada y estable, lo que constituye un factor protector. No se identifican síntomas depresivos clínicamente significativos, aunque sí se observa una *ansiedad leve*. En el contexto familiar, los padres reportan frustración y tensión derivadas de la inatención, lo que podría influir en su autoconfianza. En el entorno escolar, las manifestaciones son menos notorias, lo que sugiere que las rutinas estructuradas y el acompañamiento constante facilitan su adaptación.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164		ST-CAS18-F
			Versión: 001
			Fecha: 08/06/2022
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO		Página 12 de 16

Su estilo de aprendizaje es *predominantemente cinestésico*, lo que implica que asimila mejor la información a través de la acción, la manipulación y la experiencia directa.

ANÁLISIS DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ATENCIÓN

➤ Inatención e Hiperactividad (SNAP-IV, EDAH, TDAH-5)

Instrumento	Contexto	Dominio	Resultado Clave
SNAP-IV	Hogar	Inatención	1.56 (Por encima del punto de corte).
SNAP-IV	Escuela	Inatención	1.33 (Por debajo del punto de corte).
TDAH-5	Hogar (Padres)	Inatento (Escala 1)	Percentil 86 (ALTO).
TDAH-5	Escuela (Maestros)	Inatento (Escala 1)	Percentil 50 (BAJO).
EDAH	Ambos	DA y H+DA	Debajo de la media de corte.
SNAP-IV/TDAH-5	Hogar	Hiperactividad	Por debajo de corte/Percentil 75 (BAJO).

Existe una **alta sintomatología de inatención** reportada por los padres (TDAH-5: Percentil 86 en Inatención), pero los docentes reportan un nivel de síntomas de TDAH bajo. La severidad de los síntomas y el criterio de "Deterioro en múltiples contextos" se cumple por la *afectación funcional* que se observa en:

➤ Atención Sostenida e Impulsividad (Test CARAS-R)

- **Aciertos Netos: 48 (ALTO).** Indica una capacidad visoperceptiva y atencional adecuada cuando está motivado y la tarea es corta.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	ST-CAS18-F
		Versión: 001
		Fecha: 08/06/2022
		Página 13 de 16

- **Errores: 2 (ALTO).** El número alto de errores sugiere una tendencia a la rapidez y la omisión de detalles.
- **Índice de Control de Impulsividad: 92 (MEDIO).** Su control de impulsividad es promedio, no es el perfil de un niño con TDAH-Hiperactivo, pero presenta fatiga atencional y la alta tasa de errores sugieren que la atención sostenida y la monitorización fallan con el tiempo. El perfil es consistente con el TDAH Inatento.

➤ **Análisis Emocional y Comportamental**

- **Depresión (CDI):** Puntuación de 12. **No hay** sintomatología depresiva.
- **Ansiedad (SPENCE):** Puntuación de 38. **Sintomatología leve** de ansiedad infantil.
- **Autoestima (Rosemberg):** Puntuación de 30/40. **Autoestima elevada (Normal).**
- **Estilo de Aprendizaje (PNL):** **Cinestésico dominante.** *Antonio* aprende haciendo, tocando y moviéndose. La enseñanza tradicional, pasiva (auditiva/visual pura) será ineficiente.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	ST-CAS18-F
		Versión: 001
		Fecha: 08/06/2022
		Página 14 de 16

IV. CONCLUSIONES

El perfil neuropsicológico de *Antonio* se caracteriza por un **funcionamiento intelectual global promedio**, con *fortalezas en el razonamiento verbal y abstracto y debilidades a nivel atencional*. Se sugiere como impresión diagnóstica:

➤ **IDx. Trastorno de déficit de atención de subtipo inatento 314.01 (F90.0).**

Este patrón interfiere con el funcionamiento y desarrollo del individuo, caracterizándose por Inatención: Seis (o más) de los siguientes síntomas han persistido durante al menos 6 meses y afectan negativamente las actividades sociales y académicas/laborales:

- a) Comete errores por descuido en tareas escolares o laborales.
- b) Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas.
- c) Parece no escuchar cuando se le habla directamente.
- d) No sigue instrucciones y no termina tareas.
- e) Dificultad para organizar tareas y actividades.
- f) Evita o muestra desagrado en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido.
- g) Pierde cosas necesarias para tareas o actividades.
- h) Se distrae fácilmente con estímulos externos.
- i) Olvida actividades cotidianas.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	
	ST-CAS18-F	Versión: 001
	Fecha: 08/06/2022	Página 15 de 16

V. PLAN TERAPÉUTICO

- Control por neuropsicología
- Control por neurología pediátrica
- **Terapia comportamental/cognitiva.** 12 sesiones Mensuales (36 por 3 meses). Enfocada en entrenamiento en planificación, organización, manejo del tiempo, y estrategias metacognitivas (monitorización de errores, fatiga atencional). Manejo de la ansiedad.
- **Terapia ocupacional.** 12 sesiones Mensuales (36 por 3 meses). Optimizar la integración cinestésica en las tareas académicas. Implementar herramientas para alerta/regulación en el puesto de estudio y mejorar la eficiencia en la transcripción/ejecución de tareas.
- **RECOMENDACIONES PARA PADRES**
 - ✓ **Priorizar la Organización:** Crear un horario visual de tareas. Dividir las tareas en pequeños bloques de tiempo con descansos activos (Estilo Cinestésico).
 - ✓ **Estrategias para la MT:** Cuando dé instrucciones, pídale a *Antonio* que las repita en sus propias palabras (para reforzar la codificación en Memoria de Trabajo). Usar listas de verificación y ayudas visuales para cada paso de una tarea.
 - ✓ **Refuerzo Positivo:** Reforzar el esfuerzo y el proceso de organización, no solo el resultado académico, para proteger el Autoestima.
- **ADAPTACIONES EN EL AULA**
 - ✓ **Alineación con Estilo Cinestésico:** Permitir que *Antonio* aprenda haciendo. Usar manipulativos en matemáticas, experimentos en ciencias. Si debe tomar apuntes, permitirle usar resaltadores, mapas conceptuales o moverse brevemente.
 - ✓ **Adaptaciones de Tareas:**
 - Reducción de la Carga de Copia: Proporcionar copias de los apuntes o material parcialmente lleno para reducir la sobrecarga de la Memoria de Trabajo.
 - Instrucciones Escritas: Todas las instrucciones complejas deben estar escritas y ser entregadas una a la vez.

	SIRAMAT S.A.S NIT: 901148855-5 Cód. de habilitación: 2000102164	
	INFORME NEUROPSICOLÓGICO	ST-CAS18-F
		Versión: 001
		Fecha: 08/06/2022
		Página 16 de 16

- ✓ Permitir el uso de herramientas de autorregulación (ej. una pelota antiestrés o un "fidget" discreto). Permitirle trabajar en un espacio con menos distractores si la fatiga atencional es evidente en tareas de larga duración.

Evaluador
ANTONIO AMARIS ARIZA

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA